Ospedale San Benigno al Mare
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
S.S.D. Fisiopatologia Respiratoria
Responsabile: Dott.ssa Federica Parodi

Salita Oregina 52
16136 Genova
Tel. 010 3539712
Fax 010 3539799

VISITA PNEUMOLOGICA CON SPIROMETRIA

Prima visita pneumologica (cod. 89.7B.9) - Spirometria globale (cod. 89.37.2)

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**KOLA Arben**	Nato a:	**Durazzo (Albania)**
Data di nascita:	**02/08/1975**	Cittadinanza:	**albanese**
Codice fiscale:	**KLORBN75M02Z100V**	Telefono:	**+39 328 405 1177**
Domicilio:	**Via Burlando 33/4, Genova**	Professione:	**muratore**

Data visita:	16-01-2025	N. accettazione:	AMB-25-0091264	CUP:	GE2501-773019
NRE:	070A50118834562	Priorità:	B (entro 10 gg)	Regime:	SSN

Accettazione: AMB-25-0091264

MOTIVO DELLA VISITA

Il pz. è inviato dal medico competente aziendale, Dott. Paolo Ghiglione, per dispnea da sforzo e tosse produttiva persistente emerse alla visita periodica del 28/11/2024. Lavora come muratore presso la Edilizia Ponente Ligure S.r.l. dal 2006; in precedenza addetto al taglio di pietre nel paese di origine. Riferisce esposizione prolungata a polveri di cemento e di silice, con uso discontinuo dei dispositivi di protezione respiratoria.

ANAMNESI

Fumatore attivo di 20 sigarette/die dal 1993 (circa 31 pack-years). Consumo di alcolici occasionale. Malattia da reflusso gastroesofageo in terapia con pantoprazolo 20 mg al bisogno. Non precedenti ricoveri. Allergia alla penicillina (orticaria nel 2010). Vive con la moglie, sig.ra Elira Kola, presente alla visita, e due figli. Da circa un anno riferisce dispnea per sforzi moderati (salire 2 piani di scale con carico), tosse con espettorato mucoso al risveglio, due episodi bronchitici nell'inverno 2023-24 trattati con antibiotico dal medico curante.

ESAME OBIETTIVO

Condizioni generali buone. Peso 92 kg, altezza 178 cm, BMI 29,0. PA 132/84 mmHg. SpO2 in aria ambiente 95%, FR 18 atti/min. Torace normoconformato, espansibilità ridotta. Murmure vescicolare diffusamente ridotto con ronchi sparsi e sibili espiratori in sede basale bilaterale. Non edemi declivi, non clubbing.

SPIROMETRIA GLOBALE

Test di reversibilità con salbutamolo 400 mcg; manovre accettabili e ripetibili.

Parametro	Basale	Teorico	% del teorico	Post broncodilatatore
FEV1 (L)	2,41	3,92	61%	2,57 (+6,6%)
FVC (L)	3,96	4,85	82%	4,08
FEV1/FVC	0,61	0,79	-	0,63
TLC (L)	7,12	6,88	103%	-
RV (L)	2,95	2,05	144%	-

Esame eseguito dalla TFCPC Elena Bruzzone secondo gli standard ATS/ERS 2019 con pletismografo corporeo. Collaborazione del pz. buona.

CONCLUSIONI

Sindrome ostruttiva di grado moderato non reversibile dopo broncodilatatore, con iperinsufflazione polmonare. Il quadro è compatibile con BPCO di grado GOLD 2 in forte fumatore; data l'esposizione professionale a silice cristallina è necessario escludere una pneumoconiosi.

Prescrizioni

- Tiotropio/olodaterolo 2,5/2,5 mcg 2 inalazioni al mattino (addestrato all'uso dell'inalatore in ambulatorio).
- TC del torace ad alta risoluzione (HRCT) e DLCO.
- Vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica.
- Invio al Centro Antifumo aziendale per percorso di disassuefazione dal fumo.

Con il consenso del lavoratore si trasmette copia del referto al medico competente, Dott. Ghiglione, per la valutazione dell'idoneità alla mansione e dell'eventuale denuncia di malattia professionale.

Controllo: tra 2 mesi con l'esito della TC. In caso di peggioramento della dispnea o febbre rivolgersi al medico curante.

Il Medico Pneumologo

Dott. Stefano Repetto
Vista la Responsabile, Dott.ssa Federica Parodi

Dott. Stefano Repetto
Specialista in Malattie dell'App. Respiratorio
Iscr. Albo n. GE-11873

Genova, 16.01.2025